

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

**Conocimientos y actitudes sobre la lactancia materna
exclusiva en madres con niños menores de 6 meses
que acuden a un centro de salud de Lima Centro
- 2025**

PROYECTO DE TESIS

PRESENTADO POR:

Alva Villalobos Jeisy
Arotoma Pari Silvia

ASESOR:

Mg. Aguirre Caldas Emerson

LIMA - PERÚ
2025

INDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN	4
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	6
1.2 REVISIÓN DE LA LITERATURA.....	13
1.3 PREGUNTA, OBJETIVOS E HIPÓTESIS	20
1.4 JUSTIFICACIÓN	21
II. MATERIALES Y MÉTODOS ENFOQUE Y DISEÑO	23
2.1 ENFOQUE Y DISEÑO.....	23
2.2 POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO (CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN)	23
2.3 VARIABLES DEL ESTUDIO.....	24
2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.....	25
2.5 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS	27
2.6 ANÁLISIS DE DATOS.....	28
III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	29
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	31

INDICE DE ANEXOS

ANEXO A.	1
Anexo B:	1
ANEXO C	1
ANEXO D	5
ANEXO E.....	Error! Bookmark not defined.

INTRODUCCIÓN

La lactancia materna exclusiva constituye uno de los sistemas humanos más importantes dentro del cuidado infantil, ya que asegura una nutrición eficaz y adecuada en los primeros meses de vida del lactante. La leche materna contiene alto contenido nutritivo y eficaz, esenciales en el recién nacido que necesita para crecer de manera saludable, además de aportar defensas naturales que fortalecen su sistema inmunológico y lo protegen contra diversas enfermedades. De igual modo, representa un vínculo afectivo profundo entre madre e hijo, favoreciendo el desarrollo emocional y psicológico del niño. A pesar de estas ventajas ampliamente reconocidas, en muchos contextos la lactancia exclusiva no se mantiene el tiempo recomendado, lo que genera preocupación en el ámbito de la salud pública.

La madre ocupa un papel central en este proceso, pues es ella es quien toma la decisión de iniciar, limitar o interrumpir la lactancia exclusiva. Esta decisión está influenciada por múltiples factores, entre los que destacan el nivel de conocimiento que posee sobre los beneficios de la práctica y las actitudes que adopta frente a ella. El conocimiento se relaciona con la información que las madres tienen acerca de la lactancia, incluyendo aspectos como su duración el valor del calostro o la manera correcta de amamantar. Por otro lado, la actitud refleja la disposición personal, creencias, emociones y percepciones que influyen en la decisión de amamantar de manera exclusiva. Ambos elementos se complementan y determinan en gran medida el éxito de la LME.

Es importante resaltar que el conocimiento y la actitud no siempre van de la mano: una madre puede estar informada, pero no mostrar disposición favorable, o, por el contrario, ser asertiva en su decisión, pero carecer de información clara que le permita superar dudas y dificultades. Factores sociales, culturales, laborales y familiares pueden crear barreras o favorecer la lactancia. En este sentido, los servicios de salud manejan una adecuada información al orientar, educar y acompañar a las madres, no solo con la información técnica, sino también con estrategias de apoyo que refuercen la seguridad y confianza en el tiempo de amamantar.

Por ello, resulta fundamental investigar sobre los conocimientos y actitudes de las madres respecto a la lactancia materna exclusiva. Comprender estas dimensiones

permitirá identificar las principales limitaciones y fortalezas en torno a la práctica, ofreciendo la oportunidad de intervenir con estrategias educativas que respondan a las necesidades de las madres. De esta manera, el estudio de la lactancia exclusiva trasciende el ámbito individual y se convierte una acción de impacto social, al promover la salud de los niños y también fortalecer el rol de la madre en este proceso de alimentación y cuidado.

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad la lactancia materna exclusiva (LME) es recomendable e importante practicarla sin límite de horario y exclusivamente desde el primer minuto de vida fuera del vientre de la madre y continuarla hasta los 6 meses de vida, eso nos quiere decir que no debemos de proporcionar ningún otro alimento o líquidos, ni siquiera agua, dado que la leche tiene diversos beneficios exclusivos para el desarrollo inmunológico, desarrollo físico, prevención de enfermedades y desnutrición. Luego de ese rango de edad (6 meses) podemos complementar la lactancia materna con alimentos saludables adecuadas para la edad del lactante; esto no quiere decir que vamos a reemplazar la lactancia materna solo la vamos a complementar, con ello vamos a contribuir un óptimo desarrollo cognitivo y habilidades motoras del niño. (1) A su vez la lactancia materna establece el inicio emocional que generan madre e hijo como es el apego la cual incrementa el lazo efectivo desde el nacimiento. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) nos menciona que la LME debe de ser proveer desde la primera hora de vida del recién nacido y proporcionar tanto sea la demanda del pequeño, cumpliendo las 24 horas del día ya que así estos niños serán menos propensos a tener las enfermedades como la neumonía y las enfermedades diarreicas. (2)

En términos internacionales tenemos a países como Alemania, España, Suiza, Suecia, Bélgica, Dinamarca, Croacia, etc., nos muestra las estadísticas en cuanto a la lactancia materna y nos menciona que existe un mínimo porcentaje de lactantes (13 % al 39%) que han sido alimentados con la leche de su madre y un alto porcentaje de niños 71% que han recibido una lactancia mixta. En estos países existe mucho la venta de fórmulas de leche, estos son aditivos sucedáneos, la cual mencionan que les dan cuando la succión del bebé es débil o tenga problemas gastrointestinales, pero sin abandonar el amamantamiento, en otros casos que adicionan la leche en fórmula es cuando la madre se encuentra en tratamientos de medicina con antibióticos y está contraindicado durante un tiempo la lactancia materna. (3)

Según la UNICEF refirió que 1 de cada 2 nacidos vivos no reciben leche materna en la primera hora del nacimiento, esto hace que no reciban los nutrientes y anticuerpos que son esenciales para crear inmunidad frente a las enfermedades y de esa manera

reducir el riesgo de que más adelante padezcan complicaciones cuando los niños se contagien de las enfermedades. (4)

A nivel mundial más de 50% de neonatos no lactan leche materna, todo ello conlleva a múltiples riesgos para su salud y desarrollo, de esa manera incrementa la posibilidad de desnutrición, retraso en el crecimiento, aparición de alergias por la falta de componentes que modulan la respuesta inmune, e incluso se ha evidenciado el aumento del síndrome de muerte súbita. En los países de América Latina y los países del Caribe nos indican que el 55% de los neonatos lactan dentro de la primera hora después de nacer, el 43% de los bebés menores de 6 meses están recibiendo leche materna exclusiva en el momento del nacimiento. (5)

A nivel nacional nos indica el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) que un 68.4% de neonatos menores de 6 meses de edad reciben lactancia materna exclusiva, siendo el área rural el de mayor porcentaje 81% (8 de cada 10 lactantes), que en la zona urbana 63% (6 de cada 10 lactantes). Aquellos departamentos que mostraron alto porcentaje en cuanto al amamantamiento exclusivo con leche de mamá fueron; Ancash (88.6 %) y Junín (87.5%). Los de menor porcentaje se refleja en el departamento de Tumbes e Ica con 43.2 % y 46.8 % respectivamente. Con dichas estadísticas se puede evidenciar que el mayor porcentaje de niños que reciben lactancia exclusiva están en la zona rural, ello es porque nos refieren que las puérperas están dedicadas a los quehaceres de hogar por lo tanto tienen mayor atención con sus menores hijos, ya que la mayoría de mujeres en la parte rural no se encuentran laborando fuera de su casa o no existe mayores oportunidades como para ausentarse y generar algún ingreso económico, agregado a ello en la zona rural existen ciertas costumbres donde “ la mujer solo sirve para la casa”. Caso contrario es con madres de la zona urbana y es por ello que se evidencia menos porcentaje de niños que reciben lactancia materna exclusiva, ya que las madres retornan a su trabajo poco tiempo después del parto y por ello se les facilita el implementar dar fórmula, a ello se le agrega el desconocimiento y la mala percepción de que la fórmula es equivalente o superior a los nutrientes de la leche materna. (6)

Es importante tener presente que dar leche materna de manera exclusiva es recomendable ya que es el primer alimento de un recién nacido, de hecho, según la OMS nos refiere que la lactancia materna es como la vacuna perfecta, porque en las

primeras lactancias que recibe el niño se pueden encontrar componentes bioactivos presentes en la leche y otros fluidos corporales con funciones inmunológicas, antimicrobianas, nutritivas valiosos para el desarrollo. Aquellos lactantes que reciben lactancia durante las primeras horas de vida extrauterina, forman un microbiota rico en lactobacillus y bifidobacterias ayudando a mantener un buen estado intestinal previniendo diarreas y estreñimientos, por otro lado, el beneficio no solo es para el recién nacido sino también para la mamá. (7)

En la práctica de la lactancia materna podemos identificar una variedad de actitudes que influyen en la decisión de las madres en la negación por la lactancia materna exclusiva; entre estas actitudes destaca la idea errónea de que dar pecho puede causar aumento de peso en la madre, deformación de los senos, creer que su leche no le alimenta lo suficiente, asumir que las fórmulas son igual o mejor que la leche materna. Estas ideas están generalmente asociadas a la falta de información y a mitos culturales que se mantienen a lo largo del tiempo. Además, existen elementos que también impiden el momento de amamantar, como la percepción de “no tengo suficiente leche para alimentar a mi bebé”, el rechazo del bebé al pecho materno, la presencia de infecciones en la madre y en muchos casos, las responsabilidades laborales que impiden el tiempo y espacio necesario para amamantar adecuadamente. Estos aspectos reflejan la complejidad del entorno social y personal que enfrenta una madre lactante, donde la decisión de no dar de lactar muchas veces no proviene de una falta de interés sino de barreras reales y percibidas que no han sido abordadas de manera oportuna. (8)

Por otro lado, todavía se rescata que los adecuados conocimientos que tienen las madres sobre la lactancia materna tienen un rol crucial en el éxito de una buena actitud y con ello a una excelente práctica de esta misma. Cuando una madre cuenta con información clara, basada en evidencias y adaptada a su realidad, es más probable que se sienta segura y motivada a iniciar y mantener una alimentación únicamente con leche materna, sin complementos hasta los 6 meses. Sin embargo, muchas veces este conocimiento es limitado debido a la escasa orientación que reciben por parte del personal de salud, la falta de campañas educativas, la falta de responsabilidad de las madres para acudir a sus controles y allí reforzar dichos temas. Este déficit de apoyo y acompañamiento durante el proceso de lactancia

puede provocar inseguridad, mala actitud, dudas constantes y decisiones basadas en creencias erróneas. Por lo tanto, resulta esencial que los profesionales de salud asuman un rol activo y cercano, promoviendo espacios de educación continua y ofreciendo un respaldo emocional y técnico que permita a las madres confiar en su capacidad de alimentar y cuidar a sus hijos mediante la lactancia materna. (8)

La madre debe preocuparse en instruirse con mayores conocimientos para desarrollar de forma eficaz la responsabilidad de realizar una buena técnica de amamantamiento a su bebé en estos primeros meses, en base a la información que el propio personal de enfermería ha ido transmitiendo, así como de sus propias experiencias, vivencias de familia que sigue siendo de gran ayuda para el cuidado del bebé. El conocimiento sobre la lactancia materna, la forma y la manera de amamantar llega a ser adquirida con las pautas correctas que brinda el personal de enfermería explicando de manera clara y sencilla sobre todas las ventajas que se adquiere al dar de lactar de manera constante al bebé, A la vez explicar que la madre al dar de lactar se proteja de enfermedades y complicaciones hacia su salud, el acto de dar de lactar es significativo porque es de gran ayuda para su estado físico y emocional. (7)

De la realidad descrita anteriormente se desprende el problema ¿Cuál es la relación entre conocimientos y actitudes sobre la lactancia materna exclusiva en madres con niños menores de 6 meses que acuden a un centro de salud de Lima Centro - 2025?

Antecedentes Internacionales

Meza et, al., Desarrollaron una investigación con el propósito “ determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento y la práctica sobre la lactancia materna en madres primíparas que acudían a consultar a dos hospitales en Paraguay”, es un estudio descriptivo, analítico, la muestra estuvo compuesta por 90 madres, utilizando dos instrumentos validados; un 53% mantienen conocimiento regular respecto a la lactancia materna, otro 29% es un adecuado conocimiento y 18 con mínimo conocimiento. Como conclusión se evidenciaron que existe una relación significativa entre las dos variables la cual estuvo determinada por la prueba de estadísticas Spearman $P= 0.233$ (9)

Masud et, al., buscaron “determinar el nivel de conocimientos y prácticas sobre la lactancia materna exclusiva y su relación entre diferentes factores socioeconómicos”

El estudio fue descriptivo y transversal, con una muestra de 513 madres. Se utilizaron dos cuestionarios validados por expertos. Los hallazgos revelaron que el 95% tenía menos de 21 años e inició la lactancia inmediatamente y conocía los beneficios de amamantar; no obstante, las prácticas eran deficientes, ya que solo el 5% aplicaba las maneras correctas. En conclusión, indicaron una relación importante entre las variables, según la prueba estadística de chi cuadrado, con un valor de $p < 0,05$. (10)

Cruz et, al., Llevaron a cabo una investigación para “evaluar los conocimientos, actitudes y prácticas en relación con la lactancia materna en un hospital de México” se utilizó el estudio cuantitativo, experimental, transversal. Fueron 172 madres primerizas, para ello se aplicó una encuesta para medir conocimientos y la observación para evaluar las prácticas; los resultados arrojaron que 45.3% tiene un buen nivel de conocimiento, el 51% tiene buenas actitudes y el 62.2% nos muestra prácticas adecuadas; dando por concluida que las madres primerizas sostienen un buen conocimiento y demostraron actitudes positivas hacia la lactancia materna exclusiva y con buenas prácticas. (11)

Gaviria, en su investigación planteó el objetivo “determinar los conocimientos y prácticas relacionados con la lactancia materna exclusiva en adolescentes” El estudio tiene un enfoque cuantitativo, diseño descriptivo, transversal, se trabajó con 15 participantes. Para la recopilación de datos se emplearon un cuestionario y una guía de observación. Los resultados reflejaron que el nivel de conocimiento fue medio (45%). A partir de ello se concluyó que las adolescentes tienen un conocimiento intermedio respecto a la lactancia. (12)

Martínez et al., desarrollaron una investigación con el objetivo “evaluar el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas sobre dar de lactar en puérperas adolescentes” el estudio fue de tipo observacional, descriptivo de corte transversal, la muestra fue de 153 madres. Como instrumentos se aplicó un cuestionario y guía de observación. En cuanto a los resultados nos demuestran un buen nivel de conocimiento sobre la LME con 77.8% y una buena práctica con 69.3%. Con ello se concluyó que existe un buen nivel de conocimiento y práctica en relación LME. (13)

Tenemos a García y Fernández, señalaron “determinar los conocimientos, actitudes en relación a la lactancia materna que tienen las madres de un hospital IHAN”, es un

estudio analítico transversal, conformado por una muestra de 153 madres. En cuanto a los instrumentos se aplicaron un cuestionario y una guía de observación. Los resultados demostraron, que el 71% de madres tiene conocimiento sobre la importancia en la práctica de la LME, además saben que la lactancia materna es a libre demanda, el 92% de las madres conoce que la leche materna es el alimento ideal para el lactante. Por ello, se concluyó que las madres poseen conocimientos sobre lactancia materna, y que el 90% sale de alta con prácticas en lactancia materna. (14)

Alkhaldi et, al., Se desarrolló una investigación con la finalidad de “examinar la actitud de las madres posparto hacia la lactancia materna en Jordania en el año 2023” es un estudio transversal, con una muestra de 301 madres posparto. Se utilizó como instrumento la Escala de Actitud de Alimentación Infantil (IIFAS). Los resultados mostraron que solamente el 24.3% de madres presentó una actitud adecuada hacia la lactancia materna. Por lo que se concluyó que las madres en Jordania tienen una actitud negativa hacia la lactancia materna. (15)

Antecedentes Nacionales

Prado Inició una investigación “ determinar la relación entre el nivel de conocimiento sobre la lactancia materna exclusiva y las prácticas de amamantamiento en madres del centro de salud San José de Secce” , es un estudio descriptivo, correlacional y transversal, la muestra estuvo conformada por 28 madres primerizas, en la cual se utilizó dos encuestas; los datos revelaron que un 31.1% de las madres están informadas sobre lactancia materna, mientras que un 67% no llegó a contestar, con respecto a la práctica 75% no lo hace de la manera correcta y únicamente el 25% lo hace bien. Por ello se llegó a la conclusión de que existe una fuerte relación entre el saber y la práctica siendo esta estadísticamente con un coeficiente de Pearson de 0.91 (16)

Avellana En su investigación detalla determinar la relación que existe entre el conocimiento y la práctica sobre lactancia materna exclusiva en un hospital de Utcubamba” Se llevó a cabo un análisis descriptivo y correlacional, sin manipulación experimental, con una participación de 120 madres. Para la recolección de datos, se emplearon dos herramientas que ya habían demostrado su validez. Los hallazgos

revelaron que la gran mayoría, un 90%, mostraba un nivel intermedio, un 3.3% conocimiento limitado y solo el 6.7% demostraba un buen nivel. Con respecto a las prácticas el 38% no eran apropiadas, el 65% sí lo eran. En conclusión, indicaron una conexión relevante entre conocimientos y prácticas, según la estadística de Pearson, con un valor de $P = 0.05$ (17)

Berrocal desarrolló su investigación con el objetivo de “determinar la relación que existe entre el nivel de conocimientos y prácticas en lactancia materna en el centro de salud Chilca 2021” Es descriptivo, de corte transversal, la muestra fue con 60 participantes. Como instrumento se aplicó un cuestionario de tipo nominal. Como resultado tenemos, conocimiento bueno (7%), regular (92%) y deficiente (1%). Por lo cual se concluyó que existe un conocimiento prevalentemente “regular” en las madres adolescentes (18)

Vallejos planteó en su investigación “determinar la relación que existe entre conocimientos y prácticas LME en el Hospital Belén-Lambayeque” Es un estudio cuantitativo, no experimental, correlacional y de corte transversal, la muestra fue en 61 madres adolescentes. Para el instrumento se utilizó un cuestionario. Los resultados mostraron un conocimiento bueno y una práctica adecuada de LME en un 78.7%. Asimismo, se concluyó que existe una relación entre el nivel de conocimiento y práctica de LME. (19)

Astocondor desarrolló una investigación buscando “determinar la relación entre conocimientos y prácticas de LME en adolescentes atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal en el 2021” Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo, corre, no experimental y de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 95 participantes. En dicha investigación se llegó a aplicar 2 instrumentos: El primero un cuestionario que mide el nivel de conocimientos sobre la LME y la segunda fue una lista de cotejo que evalúa la práctica de LM. Los resultados obtenidos fueron; un nivel medio con 87% respecto a los conocimientos y un nivel alto con un 13%. (20)

1.2 REVISIÓN DE LA LITERATURA

1.2.1 Definiciones

Definición de conocimientos

El conocimiento se inicia con la experiencia vivida, el recibido y la observación constante. Es fundamental para enfrentar situaciones cotidianas, ya que permite adquirir información útil que guía la toma de decisiones. Su desarrollo se apoya en la experiencia, los valores personales y la capacidad de interpretar hechos reales a través de ideas abstractas. (21)

En el campo de la ciencia de la enfermería, el conocimiento se organiza de manera sistemática, integrando lo aprendido diariamente con la aplicación práctica. Esto permite validar procedimientos mediante el análisis crítico, la reflexión y el uso del razonamiento lógico (22)

Además, el conocimiento puede evaluarse en distintos niveles que sirven como referencia para medir la comprensión humana. Estos niveles permiten valorar el tipo de saber, ya sea empírico, objetivo o subjetivo, y suelen clasificarse como alto, medio, también como bueno, regular o deficiente, según diversos autores (23)

Tipos de conocimientos

Existen diferentes tipos de conocimientos por el cual el ser humano ha sido incorporado a sus vivencias:

Conocimiento empírico:

Se puede adquirir este conocimiento con las experiencias y pueden ser realizadas en la cotidianidad y en lo práctico. pueden darse en diferentes ámbitos como son temas políticos o éticos.

Conocimiento filosófico:

Es un saber que surge de la reflexión profunda sobre la realidad, la existencia y los valores. No se basa solo en la experiencia, sino en el razonamiento crítico. Busca interpretar los hechos y encontrar principios universales que den sentido a lo que vivimos. Se caracteriza por cuestionar y analizar lo que parece evidente.

Conocimiento científico:

Destaca por ser de un enfoque metódico, fórmula y comprueba la hipótesis, búsqueda de explicación razonable y verídica que contrarreste a algo imaginario

Conocimiento tácito:

Es el saber adquirido con la experiencia y que muchas veces no puede explicarse fácilmente. Incluye habilidades e intuiciones que se desarrollan con la práctica. Se

aplica de manera automática al realizar ciertas tareas. Es personal y difícil de transmitir de forma directa a otros.

Conocimiento teórico:

Es un saber basado en conceptos, ideas y principios que explican un fenómeno. Permite organizar la información y comprender cómo funciona algo. No requiere aplicación inmediata, pero sirve de base para la práctica.

Conocimiento práctico:

Se aplican directamente para realizar tareas o resolver problemas. Se adquiere con la experiencia y la acción, su utilidad está en la ejecución eficiente de actividades. Representa el “saber cómo” en situaciones reales.

Conocimiento cultural:

Es un conjunto de saberes, costumbres y creencias que comparte una comunidad. Se transmite de generación en generación y forma parte de la identidad colectiva. Influye en cómo interpretamos el mundo y nos relacionamos.

Conocimiento metacognitivo:

Es la capacidad de comprender y controlar el propio proceso de aprendizaje. Permite planificar, supervisar y evaluar cómo aprendemos. Ayuda a elegir las mejores estrategias para adquirir conocimientos y mejorar el rendimiento. (23)

Definición de actitud

La actitud se entiende como una disposición interna que influye en la forma en que una persona responde frente a diversas situaciones, personas o entornos. Esta se construye a lo largo del tiempo mediante la experiencia, la educación, las creencias y los valores individuales. Representa una combinación de aspectos emocionales, cognitivos y conductuales que orientan la manera de actuar (23)

En el ámbito profesional, especialmente en disciplinas como la enfermería, la actitud juega un papel fundamental, ya que impacta directamente en la calidad del cuidado brindado. Una actitud positiva, empática y ética favorece la interacción con los pacientes, el trabajo en equipo y el cumplimiento de los principios del ejercicio profesional. (24)

Al igual que el conocimiento, la actitud puede clasificarse en distintos niveles o categorías para facilitar su evaluación. Estos niveles suelen describirse como adecuados, neutros o inadecuados, dependiendo del grado de compromiso,

responsabilidad y disposición que muestra una persona en su entorno laboral o social.

Lactancia Materna Exclusiva

Es la alimentación del bebé solo con leche materna, sin añadir agua, infusiones o alimentos sólidos. Debe mantenerse durante los primeros 6 meses de vida para asegurar una nutrición óptima. Aporta defensas naturales que protegen contra enfermedades, favorece el crecimiento físico y mental del niño, también fortalece el vínculo afectivo con la madre.

Leche Materna

La leche materna es el alimento natural más adecuado para los recién nacidos y lactantes, y debe ofrecerse de manera exclusiva. Gracias a sus propiedades naturales ayuda a reducir el riesgo de enfermedades y muertes infantiles, en especial aquellas causadas por infecciones diarreicas (25)

Según la OMS, el momento del amamantamiento es fundamental en la nutrición ya que suministra una amplia gama de componentes esenciales, como aminoácidos y anticuerpos. Este tipo de alimentación fortalece el sistema inmunitario del neonato y favorece el crecimiento adecuado de sus órganos. (26)

Componentes de la leche materna

La leche materna es un alimento completo que contiene agua en gran proporción, lo que mantiene hidratado al bebé sin necesidad de otros líquidos. Aporta carbohidratos, principalmente lactosa, que brinda energía y mejora la absorción de minerales. Sus proteínas, como la lactoalbúmina y la lactoferrina, ayudan al desarrollo de tejidos y a la defensa contra infecciones. Las grasas suministran energía y ácidos grasos esenciales para el cerebro y la visión. También incluyen vitaminas, minerales y compuestos inmunológicos que fortalecen las defensas, junto con hormonas y factores de crecimiento que favorecen el desarrollo integral del niño. Respecto al hierro el organismo del bebé logra absorber cerca del 45% del hierro contenido en la leche materna, una cifra notablemente superior si se compara con la absorción del hierro en la leche de vaca (10%) o en las fórmulas infantiles (4%). La producción de leche en la madre está controlada por dos hormonas principales: la prolactina, encargada de generar leche tras la succión del bebé, y la oxitocina, que facilita su liberación desde las glándulas mamarias (27)

Etapas de la leche materna

Después del nacimiento, la leche materna experimenta una transformación gradual, la cual está dividida en tres etapas:

Calostro:

En madres primerizas, el calostro suele secretarse entre el quinto y séptimo día después del parto, mientras que en mujeres con partos previos puede aparecer de forma inmediata. Se caracteriza por una textura viscosa y una apariencia inicialmente incolora que luego se torna amarillenta. Este líquido es considerado fundamental para el recién nacido debido a su elevado contenido de proteínas, anticuerpos, células con funciones microbianas, minerales y una baja proporción de grasas e hidratos de carbono. Entre sus principales beneficios se encuentran su capacidad para proteger al neonato frente a infecciones mediante la transferencia de inmunidad pasiva y su efecto laxante que favorece la eliminación del meconio gracias a enzimas que contribuyen a la digestión de las grasas. (28)

Leche de transición:

Esta fase es la siguiente al calostro y abarca aproximadamente entre el quinto y el décimo día posparto. Su aspecto es más blanquecino. A lo largo de este periodo, su composición sufre cambios progresivos: aumenta los niveles de lactosa, grasas (incluyendo colesterol y fosfolípidos), y vitaminas hidrosolubles; mientras que disminuyen las proteínas, inmunoglobulinas y vitaminas liposolubles. (28)

Leche Madura:

La leche madura comienza a producirse a partir de la tercera semana después del parto. Su composición se modifica con el tiempo: al inicio es más líquida y saludable en lactosa, pero a medida que avanza la toma, incrementa su contenido en grasas, lo cual le proporciona mayor densidad y contribuye a la sensación de saciedad del lactante (28)

Asimismo, la lactancia materna contribuye al desarrollo emocional, sociales y psicomotor del niño, disminuye los índices de desnutrición infantil y al mismo tiempo genera un ahorro económico en el hogar. En comparación el uso de fórmulas artificiales puede asociarse a efectos adversos como alergias, estreñimiento y un mayor riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión o trastornos intestinales. (29)

Beneficios de la lactancia materna para el bebé

La leche materna ofrece múltiples ventajas para el desarrollo y el bienestar del recién nacido. Además, proporciona todos los nutrientes esenciales que el bebé requiere durante los primeros meses de vida. Contiene anticuerpos y sustancias inmunológicas que fortalecen al sistema defensivo del bebé, ayudando de esa manera a prevenir infecciones, enfermedades respiratorias y gastrointestinales. El lactante al recibir sólo leche materna le va a favorecer el desarrollo psicomotor, cognitivo y físico, también mejora la maduración del sistema nervioso y reduce el riesgo de padecer enfermedades crónicas en la vida adulta, como obesidad, enfermedades cardiovasculares y diabetes. Otro dato importante es que la lactancia contribuye al vínculo afectivo entre la madre y el pequeño, proporcionando así seguridad emocional y promoviendo un crecimiento saludable tanto físico como emocional. (30)

Beneficios de la lactancia materna para la madre

La acción de dar de lactar no solo es beneficioso para el bebé, sino aporta múltiples ventajas y beneficios para la salud física y emocional de la madre. Amamantar contribuye a una recuperación más rápida después del parto, ya que de esta manera la lactancia estimula la contracción del útero y ayuda a reducir el sangrado postparto, evitando de esa manera que ocurran hemorragias. Además, contribuye a la pérdida de peso al aumentar el gasto energético del cuerpo durante la producción de leche. (31)

Desde el punto de vista emocional, la lactancia fortalece el vínculo con el bebé, promoviendo sentimientos de bienestar y satisfacción. También se ha relacionado con una menor incidencia de depresión posparto. A largo plazo, el amamantar puede reducir el riesgo de padecer algunas enfermedades, como cáncer de mama y ovario, la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, así también como la enfermedad de osteoporosis. Estos beneficios hacen que la lactancia materna sea una práctica altamente recomendable ya que no solo es beneficioso para el niño, sino que también es importante para el bienestar de la madre (31)

La leche materna siendo un recurso natural y esencial para la supervivencia y una buena calidad de vida para los infantes, los beneficios de este alimento van más allá

de ser bueno para la madre y el niño. La lactancia materna es un elemento clave beneficios tanto sociales, familiares y ambientales.

Beneficios de la lactancia materna para la familia

En el ámbito familiar son múltiples los beneficios que se obtiene, especialmente en el aspecto económico. La lactancia exclusiva, es un ahorro para el presupuesto del hogar, al eliminar la necesidad de comprar fórmulas, biberones entre otros productos que estén relacionados a la lactancia artificial. Estos gastos son realmente elevados y continuos, se reducen de manera significativa cuando la madre amamanta. Además, con la lactancia materna disminuyen las enfermedades del lactante, se reducen los costos en las hospitalizaciones, medicinas. Todo ello contribuye a una economía más estable y al bienestar general en el hogar.

Beneficios de la lactancia materna a nivel social

La LM representa una inversión en la salud pública, generando beneficios que van más allá de la salud individual. Cuando las madres amamantan, se construye una sociedad mas fuerte y solidaria, puesto que los niños crecen con mejores defensas, menor riesgo de enfermarse y un mejor desarrollo físico y emocional. Por lo tanto, disminuye la demanda en los servicios sanitarios, menor ausentismo escolar y laboral y una mejor productividad a largo plazo. En muchas comunidades la práctica de la LM refuerza los valores culturales y el respeto que tienen hacia la maternidad, revalorizando el papel de la mujer como fuente de vida y bienestar social.

Beneficios de la lactancia materna para el ambiente

Desde una perspectiva ambiental, la LM es una práctica que contribuye a la protección del planeta, ya que al promover el amantamiento estaríamos evitando el uso de envases, transporte y procesos industriales todo lo que conlleva a generar contaminación y residuos al producir las fórmulas. La leche materna es un recurso natural, seguro y renovable por lo que no hace daño al medio ambiente. Cada madre que amamanta ayuda, de manera silenciosa a reducir el impacto ambiental y a promover un estilo de vida mas responsable con nuestro planeta. g

Frecuencia y duración de la Lactancia Materna

Frecuencia: El dar de lactar debe ser a libre demanda, el recién nacido a término, en las primeras horas no posee demasiada fuerza al succionar, por ello es indispensable que la madre se comprometa a prestar atención y no dejar más de 2

a 3 horas al recién nacido, ya que entra en una fase de adaptación al nuevo entorno. Si dejamos pasar mucho tiempo al bebé se le puede bajar la glucosa y con ello tener menos energía y estar adormitado. (28)

Duración: Con respecto a la duración del amamantamiento se puede considerar por lo menos unos 15 a 20 minutos en cada pezón, para ello tenemos que estar muy atentos a que el agarre y la succión sea de manera adecuada. (28)

Cuidado de las mamas

Durante la lactancia, es posible que las madres experimentan ciertas molestias o complicaciones en los senos. Por ello, es fundamental brindar un adecuado cuidado desde el inicio del amamantamiento, asegurando además que el bebé tenga un buen acoplamiento al pecho. Es importante mantener una higiene diaria sin utilizar jabones que puedan resecar la piel. Se recomienda el uso de sostenes cómodos y que proporcionen el soporte necesario. Para prevenir la aparición de grietas en los pezones, es esencial adoptar posturas correctas al momento de amamantar. En caso de que los senos se encuentren tensos o congestionados, se sugiere realizar masajes suaves y circulares de arriba hacia abajo para que de esa manera podamos facilitar el flujo de la leche y prevenir infecciones como la mastitis. También se recomienda mantener los senos secos y los sujetadores deben cambiarse siempre que estén húmedos, para que de esa manera se pueda reducir el riesgo de crecimiento de bacterias y hongos. (32)

Estimulación y extracción de Leche Materna

La estimulación de la lactancia debe llevarse a cabo en un lugar tranquilo y confortable, donde la madre y el bebé se sientan cómodos y relajados. La postura es clave, el bebé debe estar en contacto directo con el cuerpo y el pecho de la madre, para ello se recomienda que el bebé no tenga manoplas y así pueda sentir el contacto con su mamá. La succión del bebé favorece la producción de leche gracias a la liberación de oxitocina, hormona responsable del reflejo de eyección. La leche también puede extraerse de forma manual o con la ayuda de dispositivos como pezoneras o extractores eléctricos. En cualquier caso, es indispensable seguir normas de higiene adecuadas para evitar la contaminación del alimento (33)

Conservación y almacenamiento de la leche materna

Lo más ideal es que la leche se ofrezca directamente e inmediatamente al bebé después de ser extraída, para asegurar la conservación y el aprovechamiento de todos sus nutrientes. No obstante, puede mantenerse a temperatura ambiente (alrededor de 25 C°) por un periodo de entre 6 y 8 horas, si lo conservamos en una refrigeradora es a una temperatura de 4°C por un tiempo de 72 horas. Al momento de utilizarla debemos de calentarlo en baño maría (colocar en un envase con agua caliente) y nunca llevarla a ebullición, ya que si eso pasa podría destruir sus propiedades nutricionales. La leche calentada que no fue tomada, ya no se puede volver a refrigerar, eso se tiene que descartar. (34)

Buen Agarre

Se dice que hay un buen agarre cuando el bebé abre bien la boca y cubre gran parte de la areola (parte marrón de la mama de la mamá), los labios se tienen que evidenciar hacia afuera y el mentón tiene que tocar el pecho. Esto permite una succión profunda, una buena extracción de leche y evita el dolor en la madre.

Mal agarre

Se va a evidenciar cuando el bebé toma solo el pezón o lo hace de manera superficial. Esta posición reduce el flujo de la leche, va a dejar al niño insatisfecho y va a provocar grietas y molestias en el pezón de la mamá, cuando no hay un buen agarre el bebé succiona solo aire y puede provocar gases.

Reflejo de succión

Es una respuesta natural que aparece al estimular los labios o la boca del recién nacido, con este reflejo se impulsa la succión para obtener la leche, siendo esencial para iniciar la lactancia. También para que haya una buena succión la madre tiene que ayudar a su bebé, acercarlo a su pecho, sostener el pecho con sus dedos (puede ser en forma de una “C”), para ello la mamá tiene que estar super cómoda, si es sentada mantener su columna recta y sus rodillas ligeramente elevadas, si es acostada los dos tienen que estar “barriga con barriga”, la cabeza y el cuerpo del bebé alineados.

Reflejo de deglución

Es el mecanismo que permite al bebé pasar la leche de manera coordinada y segura, garantiza que el alimento pasa de la boca al esófago, favoreciendo una alimentación fluida esto se evidencia cuando hay un buen agarre. (34)

Mitos sobre la lactancia materna

Algunos mitos comunes son creer que la leche materna es insuficiente o que se acaba si la madre está cansada. También se piensa que las fórmulas son mejores que la leche materna, que la lactancia siempre deforma el busto. Estas ideas carecen de base científica y como consecuencia afecta la práctica de amamantar. Combatir estos mitos es clave para promover la lactancia.

Reacciones positivas y negativas de la madre hacia la lactancia materna

Las reacciones positivas incluyen la satisfacción, orgullo y conexión emocional al momento que la madre amamanta a su hijo, estas emociones positivas favorecen la lactancia. En cambio, las reacciones negativas pueden ser dolor, frustración o ansiedad, que pueden llevar a suspender la lactancia. Es importante a la hora de dar de lactar estar bien emocionalmente ya que a través de la leche materna se transmite esas emociones a los bebés. (34)

Disposición de la madre hacia la lactancia materna

La disposición de la madre para dar de lactar depende de sus creencias, conocimientos y experiencias previas. Una actitud favorable impulsa la constancia y el éxito de la lactancia. La falta de información o el miedo pueden reducir su motivación. El apoyo familiar y profesional influye en esta disposición.

1.3 PREGUNTA, OBJETIVOS E HIPÓTESIS

Pregunta de investigación

- ¿Cuál es la relación entre conocimientos y actitudes sobre la lactancia materna exclusiva en madres con niños menores de 6 meses que acuden a un centro de salud de Lima Centro - 2025?

Hipótesis

- Hi: Existe una relación entre conocimientos y actitudes sobre la lactancia materna exclusiva en madres de niños menores de 6 meses que acuden a un centro de salud de Lima Centro - 2025.

Objetivo General

- Determinar la relación entre conocimientos y actitudes sobre la lactancia materna exclusiva en madres de niños menores de 6 meses que acuden a un centro de salud de Lima Centro - 2025.

Objetivos específicos

- Analizar los conocimientos sobre la lactancia materna exclusiva en madres de niños menores de 6 meses que acuden a un centro de salud de Lima Centro - 2025
- Identificar las actitudes sobre la lactancia materna exclusiva en madres de niños menores de 6 meses que acuden a un centro de salud de Lima Centro - 2025.

1.4 JUSTIFICACIÓN

Justificación teórica

Desde una perspectiva teórica, este estudio se apoya en la promoción de la salud materno infantil y en la idea de que el conocimiento y las actitudes influyen en los comportamientos relacionados con el cuidado del niño. La lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida es fundamental para la salud del bebé y también para la madre, pero muchas veces no se practica por falta de información o por creencias erróneas. La teoría del comportamiento en salud señala que lo que las personas saben y piensan sobre una práctica influye en su decisión de llevarla a cabo. Por eso, este estudio busca conocer qué saben y qué opinan las madres sobre la lactancia exclusiva, y cómo eso afecta su forma de alimentar a sus hijos. De esta manera, se podrá comprender mejor qué factores influyen en esta práctica y cómo apoyar a las madres desde los centros de salud.

Justificación Práctica

Desde el punto de vista práctico, los resultados de este estudio pueden ser útiles para mejorar el trabajo que se realiza en los centros de salud en relación con la lactancia materna exclusiva. Al conocer qué tanto saben las madres sobre este tema y qué piensan al respecto, se podrá diseñar sesiones educativas, materiales informativos y actividades más acordes a sus necesidades y dudas reales. Además, esta información puede ayudar a que el personal de salud oriente mejor a las madres durante los controles de niño sano, brindándoles apoyo y confianza para que puedan

mantener la lactancia exclusiva por seis meses. También puede servir para identificar barreras comunes que enfrentan las madres, como creencias erróneas o falta de apoyo en casa y así buscar soluciones desde la comunidad y la familia. De esta manera se busca aportar en la mejora de la salud y el fortalecimiento del vínculo entre madre e hijo a través de la LME.

Justificación Social

Este estudio tiene un fuerte componente social, ya que se enfoca en una etapa clave del desarrollo infantil: los primeros seis meses de vida. La lactancia materna exclusiva es una práctica fundamental para garantizar la salud y el crecimiento adecuado del bebé, especialmente en familias que enfrentan condiciones económicas o sociales difíciles. Sin embargo, muchas madres no reciben la orientación y el apoyo necesario para mantener esta práctica. Al generar información sobre los conocimientos y actitudes de las madres, esta investigación busca contribuir al bienestar de los niños y al fortalecimiento del rol de la madre como cuidadora principal. También ayuda a visibilizar las necesidades de sectores de la población que suelen estar en desventaja, promoviendo una atención más equitativa y centrada en los derechos de la infancia.

Justificación metodológica

Metodológicamente, en este estudio luego de aplicar instrumentos validados y realizar un análisis estadístico adecuado, se esperan resultados confiables que futuras investigaciones pueden utilizar y para mejorar las estrategias en salud pública. Además, el diseño propuesto puede ser modelo para estudios similares en distintas zonas del país, contribuyendo al desarrollo de evidencia local en torno a la salud materno infantil.

II. MATERIALES Y MÉTODOS ENFOQUE Y DISEÑO

2.1 ENFOQUE Y DISEÑO

2.1.1 Nivel de investigación: Básica

2.1.2 Enfoque

Nuestra investigación tiene un enfoque cuantitativo, ya que según Ramos “En el enfoque cuantitativo, se efectúa un análisis de estudios estadísticos de carácter

descriptivo, que abarca medidas gráficas de dispersión y tendencia. En este tipo de análisis, se toma en cuenta valores numéricos que pueden ser medidos” (35)

2.1.3 Diseño

El diseño correlacional ya que busca ver si existe o no existe relación entre sus variables, además se tiene un diseño transversal no experimental.

Correlacional

Según Hernández, Fernández y Baptista: “ La principal finalidad y utilidad de los estudios correlacionales es determinar cómo se puede comportar una variable o concepto al analizar el comportamiento de otras variables asociadas. ” (35)

Transversal

Según Sampieri: “Los diseños transeccionales o transversales se enfocan en la recolección de datos en un solo momento, es decir, en un único período de tiempo (36)

No experimental

Según Sampieri: “ El diseño no experimental se define como un tipo de estudio que se realiza sin la manipulación intencionada de las variables. En este enfoque, se observan los fenómenos en su entorno natural y, luego, se procede a su análisis. ” (37)

2.2 POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO (CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN)

2.2.1 Población

La población de la presente investigación está conformada por madres con niños menores de 6 meses que asisten al Centro de Salud Lima Centro. Dicha población es un aproximado de 50 madres, según el padrón de seguimiento de los niños del centro de salud.

2.2.2 Muestra

Se utilizará el total de la población debido a que el tamaño del universo de estudio es reducido y accesible en su totalidad, lo que permite recolectar datos de manera integral sin comprometer la viabilidad del estudio. En este caso se aplicará un muestreo censal, el cual consiste en trabajar con toda la población objetivo, considerando a cada uno de sus integrantes dentro del análisis.

2.2.3 Criterios de inclusión y exclusión

Criterios de inclusión

- Madres con niños menores de 6 meses
- Madres que acepten participar de manera voluntaria del estudio
- Madres que asisten permanentemente en el centro de salud

Criterios de exclusión

- Madres con niños que presenten enfermedades graves que impidan la lactancia materna
- Madres con niños mayores de seis meses
- Madres con dificultades cognitivas que imposibiliten responder los instrumentos
- Madres que no acepten por medio del consentimiento informado participar de la investigación
- Madres que no hayan cursado ningún grado de educación básica

2.3 VARIABLES DEL ESTUDIO

2.3.1 Conceptual

Variable 1: Conocimiento sobre la lactancia materna exclusiva

- Definición conceptual: El conocimiento sobre la lactancia materna exclusiva se entiende como el grado en que una madre conoce sobre la importancia y los beneficios de alimentar únicamente con leche materna a su hijo durante los primeros seis meses de vida. Este saber incluye comprender que la leche materna es el alimento más completo, que no necesita complementos como agua en infusiones y que protege al bebé de enfermedades comunes. También abarca el reconocimiento de su valor para el desarrollo físico, emocional y cognitivo del niño, así como los beneficios que aporta a la salud de la madre. Contar con este conocimiento permite tomar decisiones informadas y mantener una práctica adecuada que favorece tanto al recién nacido como a la familia.

Variable 2: Actitudes de las madres sobre la lactancia materna exclusiva

- Definición conceptual: Las actitudes de las madres frente a la lactancia materna exclusiva se refieren a la forma en que ellas valoran, aceptan o rechazan esta práctica durante los primeros seis meses de vida del niño. Estas actitudes pueden ser positivas, cuando la madre muestra disposición confianza y compromiso con la

lactancia; o negativas, cuando existen dudas, creencias erróneas o falta de interés por mantenerla. Influyen factores como la información recibida, apoyo familiar y social, así como las experiencias personales de cada madre. Recordar estas actitudes es fundamental para comprender las decisiones que toman al respecto a la alimentación de sus hijos.

- Definición operacional en cuadro de operacionalización de las variables en Anexo (B)

2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

En este estudio, se empleará un cuestionario como herramienta principal de recolección de datos, utilizando el cuestionario como técnica para diagnosticar las variables del grupo de participantes.

Variable N° 1 Conocimiento

Se aplicará un cuestionario validado que lleva por título “Conocimiento sobre Lactancia Materna Exclusiva”, extraído de la tesis de Diana Astocondor de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Dicho cuestionario se divide en las siguientes partes: el título, la presentación, datos generales y 17 ítems dicotómicos la cual se usarán para evaluar el nivel de conocimiento sobre la LME en sus dimensiones: generalidades, beneficios, técnicas de la lactancia materna

Se considerarán como opciones las respectivas respuestas: SI o No; en donde la puntuación será: Respuesta Si 2 puntos y respuesta No 1 punto.

Puntuación del conocimiento

- Conocimiento bajo: 15 - 20 puntos
- Conocimiento medio: 21 - 26 puntos
- Conocimiento alto: 27 - 34 puntos

2.4.1 Validación

El cuestionario de conocimientos sobre la LME, fue validado en el año 2021 por la autora Diana Astocondor a través del juicio de expertos de 10 profesionales de enfermería con experiencia en el campo asistencial en el Perú, con un resultado de 99.1% dando respaldo a su validez para su investigación. (20)

2.4.2 Confiabilidad

Respecto a la confiabilidad de la variable, se obtuvo un coeficiente de 0.99 aplicando el estadígrafo KR-20, herramienta utilizada para evaluar la consistencia interna de instrumentos con preguntas de tipo dicotómico. Dicho resultado evidencia un nivel de confianza muy elevado, lo que indica una consistencia interna altamente significativa. (20)

Variable N° 2 Actitud

Se aplicará el cuestionario validado que lleva por título “Actitudes hacia la lactancia materna exclusiva en madres primíparas” la cual fue extraída de la tesis del autor Lucio Sulca Jesusa de la Universidad Nacional Federico Villarreal. El cuestionario presenta 15 ítems, dividido en 4 dimensiones: Disposición, lactancia exitosa, lactancia y trabajo, mitos y creencias. Se calificó cada respuesta correcta con 4 puntos y cada respuesta incorrecta 0 puntos. En total se obtienen 60 puntos. La puntuación de la escala se obtuvo mediante la Escala de Estanones, donde: (37)

Actitud Desfavorable: Menos de 46 puntos

Actitud Medianamente Favorable: De 47 a 55 puntos

Actitud Favorable: De 56 a 60 puntos

2.4.3 Validación

Para la validación de contenido de los instrumentos participaron 12 jueces expertos. En la cual estuvieron enfermeros especialistas y capacitadas en lactancia materna. Para el análisis estadístico de la validez fue a través del coeficiente V de Aiken, resultando 0.99, considerándose de alta validez.

2.4.4 Confiabilidad

La evaluación de la confiabilidad de dichos instrumentos requirió de un estudio piloto en el cual participaron 45 madres primíparas que asistieron al Centro de Salud Materno Infantil “Santa Anita” Obteniendo un Alfa de Cronbach de 0.81.

2.5 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

2.5.1 Autorización y coordinaciones previas para la recolección de datos

Antes de llevar a cabo la recolección de datos, resulta esencial cumplir con los aspectos éticos y administrativos que garanticen las autorizaciones necesarias de la institución donde se realizará el estudio. Para ello, se debe presentar una solicitud

formal a la dirección o responsable del establecimiento de salud, acompañado de nuestro proyecto de investigación. Dicho documento será evaluado y aprobado por la instancia correspondiente, ya sea un comité institucional o el área encargada de supervisar las actividades académicas y de investigación.

2.5.2 Aplicación de instrumentos de recolección de datos

Se coordinará previamente con el personal participante para definir fechas, horarios y condiciones adecuadas que permitan aplicar los instrumentos sin interrumpir sus actividades ni generar incomodidades. La aplicación se realizará en el servicio de CRED, espacio en donde la participante es atendida de manera personalizada, ahí será donde se compartirá las hojas del cuestionario luego de haber obtenido la firma del consentimiento informado. Al finalizar, se expresará el agradecimiento correspondiente y se le recalcará que la información proporcionada es totalmente anónima y será utilizada únicamente con fines académicos.

2.6 ANÁLISIS DE DATOS

Los datos obtenidos de la recopilación a través de los instrumentos aplicados serán revisados e ingresados a una base de datos en el programa Excel. Luego de ello, se exportarán a un software SPSS V 29. Se utilizará la estrategia de análisis de Spearman, en la cual se analizará valores como frecuencia y porcentajes realizando comparaciones de variables la cual ayudarán a obtener resultados confiables para la investigación.

2.6.1 Aspectos Éticos

Se pondrá en manifiesto todos los valores éticos en la investigación, tales como el compromiso de la confiabilidad, ya que, es de carácter anónimo y voluntario, por tal motivo se solicitará un consentimiento informado haciendo de que la participación será libre.

Beneficencia: Este principio ético tiene como propósito contribuir y beneficiar a los participantes, sin tener intereses lucrativos o personales.

Autonomía: Cada persona toma la decisión de manera voluntaria de querer o no participar de la investigación.

Justicia: Cada participante tendrá un trato justo e igualitario dentro de la investigación.

[illegible]

16	Sustentación de informe final												X	X
----	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

Presupuesto de proyecto

Materiales	2025				TOTAL
	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	S/
Equipos			-		
Laptop			1500		1500
USB			20		20
Útiles de escritorio					
Lapiceros			10		10
Hojas bond			15		15
Materiales Bibliográficas					
Libros			-		
Fotocopias		10	10		20
Impresiones			15		15
Espiralado			-		
Otros			-		
TOTAL		10	1570		1580

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Generador M. Vista de Beneficios de la lactancia materna en niños [Internet]. Investigarmqr.com. [citado el 10 de abril de 2025]. Disponible en: <https://www.investigarmqr.com/ojs/index.php/mqr/article/view/674/2672>
2. Lactancia materna [Internet]. Quien.int. [citado el 10 de abril de 2025]. Disponible: <https://www.who.int/es/health-topics/breastfeeding>
3. Theurich MA, Davanzo R, Busck-Rasmussen M, Díaz-Gómez NM, Brennan C, Kylberg E, et al. Tasas y programas de lactancia materna en Europa: una encuesta de 11 comités y representantes nacionales de lactancia materna. J Pediatr Gastroenterol Nutr [Internet]2019;68(3):400-7. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1097/MPG.0000000000002234>
4. Unicef.org [citado el 10 de abril de 2025]. Disponible en: <https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/en-todo-el-mundo-77-millones-de-reci%C3%A9n-nacidos-no-reciben-leche-materna-en-su>
5. Lactancia materna y alimentación complementaria [Internet]. Paho.org [citado el 10 de abril de 2025]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/lactancia-materna-alimentacion-complementaria>
6. INEI. Instituto Nacional de Estadística e Informática [Internet]. Gob.pe. [citado el 10 de abril de 2025]. Disponible en: <https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/el-684-de-ninas-y-ninos-menores-de-seis-meses-de-edad-recibio-lactancia-materna-exclusiva-durante-el-ano-2020-12901/>
7. Hernández Magdariaga A, Hierrezuelo Rojas N, González Brizuela CM, Gómez Soler U, Fernández Arias L. Conocimientos de madres y padres sobre lactancia materna exclusiva. MEDISAN [Internet]. 2023 Abr [citado el 10 de abril de 2025]; 27(2). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192023000200001&lng=es.%20%20Epub%2011-Mar-2023
8. Pomahuali Manguay MG. Conocimiento, actitudes y práctica en lactancia materna de las madres que acuden al puesto de salud tres de diciembre-Huancayo 2017. [Tesis de enfermería]. Huancayo: Universidad

Nacional de San Agustín de Arequipa Escuela de Postgrado; 2019 [citado 10 abril de 2025]. Disponible en:

<https://repositorio.unsa.edu.pe/server/api/core/bitstreams/49ffaad5-a8c0-4b00-9bec-811a5dba245d/content>

9. Meza E. Servin R. Borda L. Conocimiento y práctica sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas que acuden a consultar a dos hospitales amigo del niño de Paraguay. [Internet] jun.2021 [citado el 30 de abril de 2022]; 12(1) Disponible en: <https://revistascientificas.una.py/index.php/rdgic/article/view/967>.

10. Masud R. Rafiqul I. Reazul K. Ahmed Z. Knowledge and practice of exclusive breastfeeding mothers rural áreas of Rajshahi district in Bangladesh community clinicbased study [Internet] May 2020 [citado el 30 de abril de 2022]; Disponible en: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232027>

11. Cruz M. Obregón C. Bautista J. Conocimiento, actitudes y prácticas en relación con la lactancia materna en primigesta de 15 a 19 años que asistieron al hospital Amistad México-Nicaragua, Ticuantepe, Managua en el período del 1 de julio al 31 de diciembre [Tesis para optar el título de doctor en medicina y cirugía general] Managua Nicaragua Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 2019. Disponible en: <https://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/14205/1/14205.pdf>

12. Gaviria J. Conocimientos y prácticas en lactancia materna exclusiva a madres adolescentes en una IPS de Barranquilla. [Tesis para optar al grado de licenciatura en enfermería]. Colombia: Universidad Simón Bolívar; 2021. Disponible en: <https://bonga.unisimon.edu.co/handle/20.500.12442/8685?show=full>

13. Martínez A. López J, Blanco E. Conocimientos, actitudes y practicas sobre lactancia materna en adolescentes puérperas ingresadas al servicio de Puerperio Fisiológico del Hospital Escuela Bertha Calderón Roque, Departamento de Managua, en el periodo del 1° de octubre de diciembre del 2018. [Tesis para optar al Título de Doctores en Medicina y Cirugía]. Nicaragua: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua; 2019. Disponible en: <https://repositorio.unan.edu.ni/12501/7/12501.pdf>

14. García N, Fernández P. Conocimientos y actitudes de las madres ante la lactancia materna en un hospital IHAN. Rev Metas Enferm. [Internet]. 2018; 21(1):50-8. Disponible en: <https://www.enfermeria21.com/revistas/metas/articulo/81174/>
15. Alkhaldi SM, Al-Kuran O, Aladwan MM, Dabbah TA, Dalky HF, Badran E. Determinants of breastfeeding attitudes of mothers in Jordan: A cross-sectional study. PloS One [Internet]. 2023 [citado el 20 de septiembre de 2023];18(5):10-23. Disponible en: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0285436>
16. Prado B. Relación entre el nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva y prácticas de amamantamiento en madres primigestas del centro de salud San José de Secce [Tesis de enfermería] Perú Universidad Autónoma de Ica 2021. Disponible en: <https://repositorio.autonomadeica.edu.pe/bitstream/20.500.14441/1355/1/Betzabé%20Prado%20Fernández.pdf>
17. Avellaneda L. Conocimiento y práctica sobre lactancia materna exclusiva en madres que acuden al servicio de crecimiento y desarrollo del hospital Santiago Apóstol Utcubamba Chinchá [Tesis de Posgrado]. Bagua Grande, Perú Universidad Politécnica Amazónica 2021. Disponible en: <https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/6608943>
18. Berrocal M, Flores B, Solano O. Conocimiento y prácticas sobre lactancia materna en madres adolescentes en el Centro de Salud, Chilca 2021. [Tesis para optar el título profesional de licenciada en enfermería] Huancayo: Universidad Continental; 2022. Disponible en: https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/11748/1/IV_FCS_504_TE_Berrocal_Flores_%20Solano_2022.pdf
19. Vallejos Y. Conocimiento y práctica de lactancia materna exclusiva en madres adolescentes del Hospital Provincial Docente Belén, Lambayeque-2019. [Tesis para optar el título profesional de: licenciada en enfermería] Lima: Universidad Nacional Señor de Sipán; 2022. Disponible en: <https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/9605/Vallejos%20ORam%20%c3%adrez%20Yanet.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

20. Astocondor D. Nivel de conocimiento y práctica de lactancia materna de madres adolescentes atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal-Lima 2021. [Tesis para optar el título profesional de: licenciada en enfermería] Lima: Unoversidad Nacional Federico Villarreal; 2021. Disponible en: https://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13084/5177/UNFV_AS TOCONDOR MITMA DIANA CAROLINA TITULO PROFESIONAL 2021.pdf?sequence=3&isAllowed=y
21. Ramírez Augusto V. La teoría del conocimiento en investigación científica: una visión actual An Fac. med. [Internet]. 2009 Sep [citado el 04 de junio de 2025];70(3):217-224. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832009000300011&lng=es.
22. Parrado Lozano YM, Caro Castillo CV. Significado, un conocimiento para la práctica de enfermería. av.enferm.[Internet]. Diciembre de 2008 [citado el 4 de junio de 2025]; 116-125. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-45002008000200013&lng=en.
23. Organización Mundial de la Salud (OMS). Conocimiento, actitud y práctica: los tres pilares de la excelencia y la sabiduría: un lugar en la profesión médica. [Internet] 1995. [citado el 10 de junio de 2025]. Disponible en: <https://www.emro.who.int/emhj-volume-1-1995/volume-1-issue-1/article1.html>
24. Espinoza Venegas M, Luengo Machuca L, Sanhueza Alvarado O. Actitudes en profesionales en enfermería chilenos hacia el cuidado al final de la vida. Análisis multivariado. Aquichán [Internet]. Octubre de 2016 [citado 4 de junio de 2025]; 16(4):430-446. Disponible en: <https://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/5732/pdf>
25. Salazar S, Chávez M, Delgado X, Pacheco ERT. Lactancia materna. Arch Venez Puer Ped [Internet]. 2009 Dic [citado 04 de junio de 2025];72(4):163-166. Disponible en: https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-06492009000400010&lng=es

26. Mandia N. Concentración de los minerales oligoelementos esenciales y oligoelementos tóxicos en la leche materna y las fórmulas [tesis de Doctorado] España, Universidad Santiago de Compostela 2021. Disponible en: https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-06492009000400010&lng=es
27. Almeida Vilca JC. Lactancia materna exclusiva como factor protector asociado a hospitalización prolongada por infección respiratoria aguda en menores de 3 años en el Hospital Vitarte entre enero del 2019 y diciembre del 2021 [tesis]. Lima (Perú): Universidad Ricardo Palma; 2024. [citado 05 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://repositorio.urp.edu.pe/server/api/core/bitstreams/d1787c2d-dc82-482d-baf9-b6e4ba5d8b74/content>
28. López de Aberasturi Ibáñez de Garayo Ayala, Santos Ibáñez Nerea, Ramos Castro Y, García Franco M, Artola Gutiérrez C, Arara Vidal I. Prevalencia y determinantes de la lactancia materna: estudio de Zorrotzaurre. Hospital Nutrir [Internet]. febrero de 2021 [consultado el 21 de agosto de 2025]; 38(1): 50-59. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112021000100050&lng=es
29. Morales López S, Colmenares Castaño M, Cruz Licea V, Iñarritu Pérez MC, Maya Rincón N, Vega Rodríguez A, et al. Recordemos lo importante que es la lactancia en México. Rev. Fac. Med. (Méx)[revista en internet]. Abril 2022 [citado 04 de junio de 2025];65(2):9-25. Disponible en: https://www.revistafacmed.com/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=1496:recordemos-lo-importante-que-es-la-lactancia-materna&Itemid=79
30. Brahm P, Valdés V. Beneficios de la lactancia materna y riesgos de no amamantar. Rev. chil. pediatr. [Internet]. 2017 [citado 04 de junio de 2025]; 88(1):07-14. Disponible en: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062017000100001&lng=en&nrm=iso&tlng=en

31. Beneficios de la Lactancia materna - Ministerio de Salud Pública. Gob.ec. [Internet]. Ecuador: [actualizado 04 de junio de 2025; citado el 25 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://www.salud.gob.ec/beneficios-de-la-lactancia-materna/>
32. Hermosin A, Oereira E, Calviño I. Cuidado de enfermería en la mastitis [Internet] 2017 Agosto [citado el 09 de mayo de 2025]. Disponible en: https://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/cuidados-enfermeria-las-mastitis/#google_vignette
33. Ministerio de Salud del Perú. Leche materna: extracción, conservación y consumo [Internet]. Perú: Gobierno del Perú; 2024 [citado 01 agosto 2025]. Disponible en: <https://www.gob.pe/25545-leche-materna-extraccion-conservacion-y-consumo>
34. Hernandez Sampieri R, Fernandez y Bapista. Metodología de la investigación Capítulo IV Udlap.mx. Disponible en: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lcp/texson_a_gg/capitulo4.pdf
35. Hernandez Sampieri R, Mendoza C. Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa cualitativa y mixta. [citado 23 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://n9.cl/832bd>
36. Hernandez Sampieri R, Fernandez y Bapista. Metodología de la investigación capítulo III Urbe.edu-cap III. Disponible en: <https://virtual.urbe.edu/tesispub/0095394/cap03.pdf>
37. Aquino A, Hamilton R, Bello V, Ramirez Julcarima C. Edu.pe. [Internet]. [citado 04 de junio de 2025]. Disponible en: https://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13084/8607/UNFV_FM_HU_Lucio%20Sulca%20Jesusa%20Nicol_Titulo%20profesional_2024.pdf?sequence=1&isAllowed=y
38. de Salud PM, Pública D, de la Salud DG de P. Guía técnica para la consejería en lactancia materna. 2019 [cited 2025 Nov 11];52–52. Available from: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/471230/130173163268756829820191231-7797-gbg6j.pdf?v=1577827973>

ANEXOS

ANEXO A.

MATRIZ DE CONSISTENCIA INTERNA

Pregunta	Objetivos	Hipótesis	Variables	Dimensiones	Metodología
¿Cuál es la relación entre conocimientos y actitudes sobre la lactancia materna exclusiva en madres con niños menores de 6 meses que acuden a un centro de salud de Lima Centro - 2025?	Objetivo general Determinar la relación entre conocimientos y actitudes sobre la lactancia materna exclusiva en madres de niños menores de 6 meses que acuden a un centro de salud de Lima Centro - 2025. Objetivos específicos Analizar los conocimientos sobre la lactancia materna exclusiva en madres de niños menores de 6 meses que acuden a un centro de salud de Lima Centro - 2025 Identificar las actitudes sobre la lactancia materna exclusiva en madres de niños menores de 6 meses que acuden a un centro de salud de Lima Centro - 2025.	Hi: Existe una relación entre conocimientos y actitudes sobre la lactancia materna exclusiva en madres de niños menores de 6 meses que acuden a un centro de salud de Lima Centro - 2025.	V1: CONOCIMIENTOS	Generalidades Beneficios Técnicas Agarre Succión	Tipo: Cuantitativo Diseño: No experimental de corte transversal Población: 50 Madres de niños menores de 6 meses Muestra: No se realizó muestra ni muestreo Técnica Instrumento: Cuestionario
			V2: ACTITUDES	• Disposición • Lactancia exitosa y • Lactancia y • Mitos y creencias	

Anexo B: OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE

VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADORES	ESCALA DE MEDICIÓN	CRITERIOS PARA ASIGNAR VALORES
CONOCIMIENTOS SOBRE LME	Se entiende como la capacidad de comprender y asimilar información relacionada con esta práctica, obtenida mediante la enseñanza, experiencia y el aprendizaje. Implica el uso de la razón, la comprensión para reconocer la importancia de alimentar al niño menor de 6 meses con únicamente leche materna	Es el criterio que tiene la madre con respecto a los conocimientos, teóricos y prácticos sobre la LME.	Generalidades	Definición Composición de la leche materna Etapas de la leche materna	Nominal	Conocimiento Bajo: 15 – 20 puntos Conocimiento medio: 21 – 26 puntos Conocimiento alto: 27 – 34 puntos
			Beneficios	Beneficios para el lactante Beneficios para la madre		
			Técnicas	Extracción Almacenamiento		
			Agarre	Buen agarre Mal agarre		
			Succión	Reflejo de succión Reflejo de deglución		

ACTITUDES	Las actitudes de las madres hacia la lactancia exclusiva son predisposiciones que nacen en sus ideas y experiencias. Estas se manifiestan en la manera en que aceptan o rechazan la práctica, pudiendo mostrar así confianza y compromiso o caso opuesto dudas e inseguridades.	Son las actitudes de las madres que serán evaluadas en el centro de salud, en la cual se evaluará diferentes dimensiones.	• Disposición • Lactancia exitosa • Lactancia y trabajo. • Mitos y creencias	Mitos acerca de la lactancia materna exclusiva. Reacción de la madre hacia la lactancia materna exclusiva. Disposición de la madre hacia la lactancia materna exclusiva	Ordinal	Actitud desfavorable: Menos de 46 puntos Actitud medianamente favorable: 44 a 55 puntos Actitud favorable: 56 a 60 puntos
-----------	---	---	---	--	---------	--

ANEXO C

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS INSTRUMENTO PARA EVALUAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA

Instrumento de Astocondor Mitma D. (2021)

Estimada madre, reciba un cordial saludo y nuestro agradecimiento por brindarnos unos minutos de su valioso tiempo. Nosotras somos Jeisy Alva Villalobos y Silvia Arotoma Pari, estudiantes de la Universidad de Ciencias y Humanidades. El presente cuestionario está dirigido a madres de niños menores de seis meses, con el objetivo de analizar la relación entre conocimientos y actitudes sobre la lactancia materna exclusiva en aquellas que acuden a un centro de salud Lima Centro en el año. la información que usted proporcione será totalmente anónima y confidencial, por lo cual le pedimos responder con sinceridad, ya que sus aportes serán de gran importancia para el desarrollo de este estudio.

INSTRUCCIONES: Leer detenidamente las preguntas y marcar con un aspa (x) la respuesta que usted considere correcta.

I. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

1. Edad (años)..... Edad del menormeses
2. Número de hijos:
1 Hijo () 2 Hijos () 3 Hijos () Mas de 4 hijos ()
3. Grado de Instrucción
Primaria () Secundaria () Técnico completo () Universitaria ()
4. Estado civil:
Soltera () Casada () Conviviente () Divorciada () Viuda ()
5. Ocupación
Ama de casa () Estudiante () Dependiente () Independiente ()
6. Lugar de procedencia
7. Lima () Provincia ()

CUESTIONARIO SOBRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA

Marque con "X" una sola alternativa

ENUNCIADOS	SI	NO
1. Todas las mujeres son capaces de brindar leche materna a su bebé recién nacido.		
2. La lactancia materna exclusiva es brindar leche materna y agüita al bebé.		
3. La lactancia materna exclusiva debe prolongarse hasta más de seis meses.		
4. El bebé debe ser alimentado con leche materna desde que nace, esta primera leche se llama calostro.		
5. El niño debe recibir leche materna cada vez que lo desee (a libre demanda).		
6. La lactancia materna ayuda a prevenir el cáncer de mama y algunas formas de cáncer de ovario.		
7. La lactancia materna proporciona al bebé defensas contra las enfermedades.		
8. La lactancia materna disminuye la posibilidad de hemorragia después del parto.		
9. Los niños que recibieron lactancia materna exclusiva tienen mayor desarrollo intelectual que los que fueron alimentados con leche de fórmula.		
10. La lactancia materna ayuda a crear y mantener una relación de afecto entre la madre y el bebé.		
11. Los masajes en las mamas antes de dar de lactar, facilita la salida de la leche.		
12. La succión del bebé estimula el incremento de leche materna.		
13. La leche de fórmula es la mejor opción para las madres que estudian o trabajan.		
14. La leche materna se puede contaminar cuando se conserva en la refrigeradora a lado de otros alimentos (carne, pescado, pollo, etc.)		
15. La leche materna guardada en la refrigeradora debe hervirse antes de ser consumida por el bebé.		
16. La mujer que da de amamantar puede comer y beber de todo.		
17. Se debe comer doble para poder amamantar.		

CUESTIONARIO PARA MEDIR LA ACTITUD DE LAS MADRES SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA

N°	ITEMS	Muy de acuerdo	De acuerdo	Indiferente	En desacuerdo	Muy en desacuerdo
	DIMENSIÓN: DISPOSICIÓN					
1	La madre siempre se organiza para tener tiempo de amamantar a su bebé.					
2	La madre debe ofrecer su pecho al bebé cada vez que este lo desee.					
3	Las madres no pueden amamantar al bebé en lugares públicos.					
4	La madre amamanta a su bebé aun cuando está cansada.					
	DIMENSIÓN: LACTANCIA EXITOSA					
5	Ofrecer fórmulas lácteas a los bebés los hace más saludables.					
6	Dar pecho hace que crezcan lazos de amor entre la madre y su bebé.					
7	Estar cómoda y sin estrés ayuda a la madre a producir más leche					
8	Despertar en la noche para amamantar ocasiona molestias a la madre.					

	DIMENSIÓN: LACTANCIA Y TRABAJO					
9	Dar fórmula es la mejor opción para la madre que sale a trabajar o estudiar					
10	La leche extraída se puede ofrecer en biberón al bebé.					
	DIMENSIÓN: MITOS Y CREENCIAS					
11	Todas las mujeres están preparadas para amamantar a su bebé					
12	Amamantar al bebé daña los pechos y el cuerpo de la mujer.					
13	Se debe suspender la lactancia materna en el bebé enfermo.					
14	Tomar cocoa, avena y líquidos ayuda a aumentar la cantidad de leche materna.					
15	El apoyo familiar es innecesario durante la lactancia materna exclusiva.					

ANEXO D

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN MÉDICA

A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación en salud. Antes de decidir si participa o no, debe conocer y comprender cada uno de los siguientes apartados.

Título del proyecto: Conocimientos y actitudes sobre la lactancia materna exclusiva en madres con niños menores de 6 meses que acuden a un centro de salud de Lima Centro – 2025

Nombre de los investigadores principales:

Alva Villalobos, Jeisy

Arotoma Pari, Silvia

Propósito del estudio: Determinar la relación entre conocimientos y actitudes sobre la lactancia materna exclusiva en madres de niños menores de 6 meses que acuden a un centro de salud de Lima Centro - 2025.

Beneficios por participar: Tiene la posibilidad de conocer los resultados de la investigación por los medios más adecuados (de manera individual o grupal) que le puede ser de mucha utilidad en su actividad profesional.

Inconvenientes y riesgos: Ninguno, solo se le pedirá responder el cuestionario.

Costo por participar: Usted no hará gasto alguno durante el estudio.

Confidencialidad: La información que usted proporcione estará protegido, solo los investigadores pueden conocer. Fuera de esta información confidencial, usted no será identificado cuando los resultados sean publicados.

Renuncia: Usted puede retirarse del estudio en cualquier momento, sin sanción o pérdida de los beneficios a los que tiene derecho.

Consultas posteriores: Si usted tuviese preguntas adicionales durante el desarrollo de este estudio o acerca de la investigación, puede dirigirse a **Alva Villalobos Jeisy**, coordinadora de equipo.

Contacto con el Comité de Ética: Si usted tuviese preguntas sobre sus derechos como voluntario, o si piensa que sus derechos han sido vulnerados, puede dirigirse a Ángel Rafael Heredia Vega, presidente del Comité de Ética de la Universidad Ciencias y Humanidades, ubicada en la av. Universitaria N°5175, Los Olivos, correo electrónico: aheredia@uch.edu.pe

Participación voluntaria: Su participación en este estudio es completamente voluntaria y puede retirarse en cualquier momento.

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO

Declaro que he leído y comprendido, tuve tiempo y oportunidad de hacer preguntas, las cuales fueron respondidas satisfactoriamente, no he percibido coacción ni he sido influido indebidamente a participar o continuar participando en el estudio y que finalmente acepto participar voluntariamente en el estudio.

Nombres y apellidos del participante o apoderado	Firma o huella digital
N° de DNI	
N° de teléfono: fijo o móvil o WhatsApp	
Correo electrónico	
Nombres y apellidos del investigador	Firma
N° de DNI	
N° teléfono móvil	
Nombre y apellidos del responsable de encuestadores	Firma
N° de DNI	
N° teléfono	
Datos del testigo para los casos de participantes iletrados	Firma o huella digital
Nombre y apellido:	
DNI:	
Teléfono	

Certifico que he recibido una copia del consentimiento informado

.....
Firma del participante

ANEXO E

APROBACIÓN DE COMITÉ DE ÉTICA



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN

ACTA CEI N.° 327	11 de setiembre de 2025
------------------	-------------------------

ACTA DE EVALUACIÓN ÉTICA

En el distrito de Los Olivos, el día 11 de setiembre del año dos mil veinticinco, el Comité de Ética en Investigación en seres humanos y animales ha evaluado el proyecto Titulado:

CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES SOBRE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN MADRES CON NIÑOS MENORES DE 6 MESES QUE ACUDEN A UN CENTRO DE SALUD DE LIMA CENTRO- 2025. Con código 277-2025, presentado por el(los) autor(es):

ALVA VILLALOBOS JEISY y AROTOMA PARI SILVIA.

Teniendo en cuenta que el mismo reúne las consideraciones éticas.

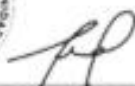
POR TANTO:

El Comité de ética en Investigación,

RESUELVE

APROBAR, el proyecto titulado: **CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES SOBRE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN MADRES CON NIÑOS MENORES DE 6 MESES QUE ACUDEN A UN CENTRO DE SALUD DE LIMA CENTRO- 2025.**

Código-277-2025



LIC. ÁNGEL RAFAEL HEREDIA VELA

Presidente
del comité de ética en investigación
Resolución N°014-2025-R-UCH

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Los Olivos, 16 de septiembre de 2025

CARTA N.º 139-2025-FCS-UCH

DR.

PEDRO ALEJANDRO CRUZADO PUENTE

Director regional de Salud de Lima Centro (Diris Lima Centro)

Centro de Salud Breña

Asunto: Autorización para recolección de
información para trabajo de investigación

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente en nombre de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Ciencias y Humanidades y a su vez presentar a nuestros(as) estudiantes del 10mo ciclo del Programa de Estudios de Enfermería:

ALVA VILLALOBOS JEISY JUDITH
AROTOMA PARI SILVIA DAYSI

CÓDIGO N.º 21102381
CÓDIGO N.º 21102085

Quienes se encuentran desarrollando un trabajo de investigación que lleva por título: **CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES SOBRE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN MADRES CON NIÑOS MENORES DE 6 MESES QUE ACUDEN A UN CENTRO DE SALUD DE LIMA CENTRO- 2025**; a fin de solicitarle su autorización y brindar las facilidades correspondientes para que puedan ejecutar y recolectar la información en la institución que usted dirige, por ser de suma importancia para la elaboración y desarrollo del trabajo de investigación.

Agradecemos por anticipado su gentil colaboración.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para manifestarle mi estima personal.

Atentamente,



Mg. DORIS MELLINA ALVINES FERNÁNDEZ
Coordinadora General
Facultad de Ciencias de la Salud
Universidad de Ciencias y Humanidades

